

ORIGINAL



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1218

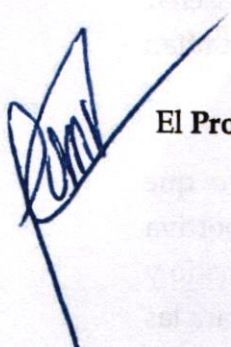
INFORME NEGATIVO

17 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1218, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1218 propone enmendar la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico" (ASES), a los fines de añadir un nuevo inciso (g) al apartado (1) de Servicios de Salud Preventivos, para incluir la evaluación médico-deportiva anual obligatoria para niños, niñas y jóvenes deportistas, y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, en los últimos años, Puerto Rico ha lamentado la pérdida repentina de jóvenes atletas que colapsaron durante entrenamientos o competencias deportivas, dejando un vacío irreparable en sus familias y comunidades. Estos sucesos han evidenciado la fragilidad de la vida y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en el ámbito deportivo infantil y juvenil.

El autor planteó que muchas de estas muertes pudieron haberse evitado mediante una evaluación médica previa que detectara condiciones cardíacas, respiratorias u otras patologías silentes que solo se manifiestan bajo el esfuerzo físico intenso. Sin embargo, en la actualidad una gran parte de nuestros niños y jóvenes deportistas participan en disciplinas exigentes sin contar con una certificación que garantice que están física y emocionalmente preparados para asumir ese reto.

Forjar un verdadero escudo protector para los atletas jóvenes exige remover el obstáculo económico que mantiene a tantos fuera del alcance de una revisión médica. Permitir que la capacidad de pago decida quién puede competir con seguridad y quién debe hacerlo a ciegas frente a su propio cuerpo es perpetuar una desigualdad profunda que contradice el espíritu protector que la Asamblea Legislativa está llamada a defender.

Se dispone además, que incluir la evaluación médico-deportiva como un servicio preventivo anual dentro del Plan de Salud del Gobierno, administrado por ASES, garantiza que ningún joven quede excluido por su condición económica. Esa visita al médico no es un trámite burocrático; representa un acto de amor y responsabilidad que permite a los padres y entrenadores conocer los límites y fortalezas de cada atleta, diseñar entrenamientos seguros y, sobre todo, devolver la tranquilidad a los hogares que confían sus hijos al deporte.

Añade que, esta medida representa un paso firme hacia un sistema deportivo que antepone la salud y la vida al rendimiento. Al integrar la evaluación médico-deportiva en los servicios preventivos de salud, cerramos la brecha entre el derecho proclamado y su ejercicio efectivo, construyendo una cultura de prevención y cuidado integral para las generaciones que representan el futuro de nuestro deporte y nuestra sociedad

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del **P. del S. 1218**, la Honorable Comisión de Salud del Senado solicitó los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES), el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP).

Igualmente, se solicitaron los comentarios al Departamento de Educación (DE), la Asociación Médica de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL); no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Departamento de Salud** presentó su memorial explicativo por conducto de su Secretario, Víctor M. Ramos Otero, expresándose en contra de la aprobación de la medida.



El Departamento de Salud expuso que, aunque reconoce el propósito preventivo que persigue el Proyecto del Senado 1218 al procurar la incorporación de una evaluación médico-deportiva anual para menores que participan en actividades deportivas federadas o escolares, la medida resulta innecesaria desde una perspectiva programática y administrativa. En ese sentido, señaló que la población beneficiaria del Plan de Salud del Gobierno ya recibe, mediante los programas federales Medicaid y *Children's Health Insurance Program* (CHIP), las evaluaciones periódicas provistas por el programa *Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment* (EPSDT), las cuales comprenden un examen integral de mayor amplitud clínica que el propuesto en la legislación.

Asimismo, puntualizó que el programa EPSDT garantiza, sin costo para los beneficiarios, evaluaciones físicas periódicas fundamentadas en los estándares de la Academia Americana de Pediatría, dirigidas a identificar oportunamente condiciones de salud que pudieran afectar el bienestar de los menores. A juicio de la Agencia, la creación de una evaluación médico-deportiva independiente duplicaría servicios preventivos que actualmente forman parte de la cubierta obligatoria del Plan Vital, generando redundancia normativa sin aportar beneficios clínicos adicionales.

Finalmente, el Departamento concluyó que, aun cuando comparte la preocupación legislativa de fortalecer la protección de los jóvenes atletas, la propuesta carece de necesidad jurídica y administrativa, toda vez que el ordenamiento vigente ya provee un mecanismo integral para atender el objetivo perseguido. En consecuencia, no endosó la

aprobación del Proyecto del Senado 1218 y recomendó que, de persistir el interés legislativo en la materia, se solicite además el insumo de los Departamentos de Educación y de Recreación y Deportes para evaluar cualquier impacto que exceda el ámbito de la cubierta médica del Plan Vital.

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

La **Administración de Seguros de Salud (ASES)** presentó ante la Comisión de Salud su memorial explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario, expresándose en contra de la aprobación de la medida.



Expuso que, si bien comparte el propósito del Proyecto del Senado 1218 de fortalecer la prevención de eventos adversos en menores que practican deportes, entiende que la medida resulta innecesaria, toda vez que el ordenamiento vigente ya garantiza una evaluación integral de la salud de esta población mediante los servicios preventivos cubiertos por el Plan Vital. En ese sentido, puntualizó que el Programa de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico (EPSDT), financiado bajo Medicaid y CHIP, provee evaluaciones médicas periódicas, exámenes físicos, servicios diagnósticos y tratamientos dirigidos a identificar oportunamente condiciones de salud y atenderlas antes de que evolucionen a discapacidades permanentes.

Asimismo, la ASES señaló que la Ley Núm. 72-1993 ya establece una cubierta amplia de beneficios médicos preventivos para los menores elegibles al Plan Vital, incluyendo visitas periódicas de bienestar, evaluaciones físicas, visuales, auditivas y dentales, así como los tratamientos clínicamente necesarios. En consecuencia, sostuvo que la evaluación médico-deportiva propuesta constituye un mecanismo adicional que no sustituye ni amplía sustancialmente los servicios preventivos actualmente garantizados por el marco normativo y programático vigente.

Aunque reconoció la importancia de promover la seguridad de los menores que participan en actividades deportivas, enfatizó que las evaluaciones integrales provistas bajo el EPSDT ofrecen un análisis más amplio y profundo del estado de salud de los beneficiarios que una evaluación enfocada exclusivamente en el aspecto deportivo. Por ello, concluyó que no existe necesidad de incorporar una cubierta adicional obligatoria dentro del Plan Vital para atender el objetivo perseguido por la medida.

En síntesis, ASES recomendó que, antes de adoptar una enmienda legislativa, se recabe el insumo del Departamento de Educación y del Departamento de Recreación y Deportes, por entender que dichas entidades poseen peritaje especializado sobre los programas deportivos dirigidos a menores y podrían aportar alternativas de política pública con un alcance más amplio que el limitado a los beneficiarios del Plan Vital.

Finalmente, reiteró que la legislación propuesta no resulta necesaria, dado que los mecanismos preventivos actualmente disponibles satisfacen los objetivos de protección y detección temprana que persigue el Proyecto del Senado 1218.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (DRD)

Recibimos, de igual forma, los comentarios del **Departamento de Recreación y Deportes (DRD)** en torno al P. del S. 1218 por conducto de su Secretario, Héctor R. Vázquez Muñiz, manifestando su respaldo categórico a la pieza legislativa al sostener que la medida atiende una necesidad apremiante de salud pública dirigida a la protección de niños, niñas y jóvenes que participan en actividades deportivas organizadas.

En ese contexto, expuso que la propuesta legislativa recoge las recomendaciones técnicas previamente formuladas por la Agencia durante la evaluación del Proyecto del Senado 1083, particularmente en cuanto a incorporar la evaluación médico-deportiva anual como un servicio preventivo cubierto por el Plan Vital, evitando así que el costo del examen constituya una barrera económica para las familias de escasos recursos.

Asimismo, el DRD puntualizó que la práctica deportiva de alto rendimiento puede revelar condiciones médicas silenciosas, especialmente cardiovasculares y respiratorias, cuya detección temprana resulta indispensable para prevenir eventos fatales en atletas menores de edad. En esa dirección, sostuvo que la inclusión de la evaluación médico-deportiva dentro de la cubierta preventiva administrada por la Administración de Seguros de Salud representa un mecanismo efectivo para garantizar un acceso equitativo a dichos servicios, independientemente de la capacidad económica de las familias.

De igual forma, señaló que la reglamentación conjunta propuesta entre la Administración de Seguros de Salud (ASES), el Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Salud permitirá uniformar los criterios clínicos aplicables a la evaluación, procurando que el cernimiento responda a estándares médicos especializados y no se limite a un examen físico de carácter general. A esos fines,

recomendó que el texto del Proyecto o su reglamentación establezcan parámetros específicos sobre los profesionales autorizados para expedir la certificación médico-deportiva, referido obligatorio a especialistas ante hallazgos clínicos sospechosos, la incorporación de un componente de salud mental, la vigencia anual de la certificación y la aplicación uniforme del requisito a toda actividad deportiva organizada, tanto pública como privada.

Finalmente, el Departamento de Recreación y Deportes concluyó que el Proyecto del Senado 1218 fortalece el marco preventivo del sistema deportivo puertorriqueño al promover la detección temprana de condiciones de salud que pudieran poner en riesgo la vida de los menores deportistas. Por ello, recomendó la aprobación de la medida, incorporando las enmiendas técnicas propuestas para asegurar su adecuada implantación y efectividad.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)



La **Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)** cursó sus comentarios a esta Distinguida Comisión en contra de la aprobación del Proyecto del Senado 1218 suscrito por su Director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Ejecutivo Senior, Lcdo. Luis R. Rivera Cruz.

Indicó que el PS 1218 propone realizar unas enmiendas a la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", que creó a la ASES como corporación pública con el propósito de negociar y administrar un sistema de seguros de salud que brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médico-hospitalarios.

Desde la perspectiva de la AAFAF, el análisis debe concentrarse en la compatibilidad de la medida con el Plan Fiscal certificado, la Ley PROMESA, el presupuesto balanceado, el principio de neutralidad fiscal, los parámetros fiscales aplicables al Gobierno de Puerto Rico y el Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

La AAFAF reconoció la loable intención del PS 1218 y la importancia de salvaguardar la salud de los atletas jóvenes mediante los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico vigente. No obstante, fundamentó que la medida propone una ampliación de los servicios cubiertos bajo el Plan de Salud del Gobierno sin identificar una fuente de fondos para sufragar el costo correspondiente. Por tanto, indicó que resulta imperativo realizar

un análisis fiscal, actuarial, jurídico y operacional riguroso antes de considerar su aprobación.

Asimismo, recalcó que al presente, la medida carece de un informe de efecto fiscal emitido por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y en ausencia de dicha evaluación de efecto fiscal, resulta imposible cuantificar el costo total que conllevaría la implantación del nuevo beneficio, determinar el universo de beneficiarios potenciales, estimar el impacto sobre las primas contratadas por la ASES, ni ponderar el efecto neto sobre el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

Para la AAFAF, el debate no radica en si el fin de la medida es loable, sino en si el instrumento sugerido se alinea con el ordenamiento fiscal de PROMESA. Añadió, que la pieza legislativa propone una ampliación del catálogo de servicios preventivos cubiertos bajo el Plan de Salud del Gobierno sin identificar fuente de fondos alguna para sufragar el gasto recurrente que ello generará.

A la luz de la información disponible y conforme a las observaciones y planteamientos que preceden, la AAFAF manifestó que tiene interrogantes fiscales sobre la medida. Sostuvo que, para poder tener un cuadro más abarcador, es medular tener la opinión de las agencias concernidas, con peritaje en asuntos fiscales y relacionados, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, la ASES, el DRD y el Departamento de Salud. Sostuvo que brindará deferencia a los comentarios que dichas entidades tengan a bien emitir en cuanto a este particular, siempre y cuando cumplan con los parámetros fiscales, el Plan Fiscal certificado y el Presupuesto balanceado.

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO (AEP)

Por su parte, la **Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP)** presentó su memorial explicativo por conducto de su Presidente, Juan Carlos Santiago y su Directora Ejecutiva, Wanda Ayala de Torres, mostrándose en contra de su aprobación.

Siendo una entidad sin fines de lucro que agrupa múltiples y diversas instituciones educativas privadas a nivel universitario, post secundario, educación básica (K-12), preescolar y escuelas maternas, reconoció la importancia de promover iniciativas dirigidas a salvaguardar la salud y la seguridad de los niños y jóvenes que participan en actividades deportivas. No obstante, puntualizó que el Proyecto del Senado 1218 parte de premisas que no están suficientemente sustentadas por datos empíricos que

demuestren la magnitud del problema que pretende atender, ni el impacto económico y operacional que conllevaría la implantación de la evaluación médico-deportiva anual obligatoria.

Asimismo, expuso que la medida omite considerar la realidad de los estudiantes cubiertos por seguros médicos privados, limitando su análisis a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno. En ese sentido, advirtió que la propuesta podría generar un trato desigual entre estudiantes y trasladar a las familias costos adicionales sin establecer un mecanismo que garantice una cubierta uniforme para toda la población estudiantil. De igual forma, señaló que el Proyecto no evalúa adecuadamente las cargas administrativas, regulatorias y económicas que podrían recaer sobre las instituciones educativas privadas.



Por otro lado, indicó que la pieza legislativa adolece de precisión normativa al no definir el alcance del concepto de "competencias escolares", ni establecer el contenido mínimo de la evaluación médica, los criterios clínicos aplicables, los profesionales autorizados para expedir la certificación correspondiente o los estándares para determinar la aptitud física de los estudiantes. A juicio de la Asociación, tales omisiones podrían propiciar interpretaciones inconsistentes, dificultar la implantación uniforme del requisito y generar incertidumbre tanto para las instituciones educativas como para los proveedores de servicios de salud y las aseguradoras.

Finalmente, concluyó que, aunque favorece toda iniciativa encaminada a proteger la salud y el bienestar de la población estudiantil, el Proyecto del Senado 1218 requiere enmiendas sustanciales antes de recibir su respaldo. En consecuencia, recomendó que la Asamblea Legislativa reevalúe la medida para atender sus implicaciones económicas, administrativas y regulatorias, delimite con precisión su alcance y garantice que cualquier obligación impuesta resulte razonable, uniforme y accesible para todos los estudiantes, independientemente del tipo de cubierta médica que posean.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Del análisis integral de los memoriales recibidos surge un consenso mayoritario entre las Agencias con competencia directa sobre la administración del Plan de Salud del Gobierno y la política pública de salud respecto a que la finalidad preventiva perseguida por el Proyecto del Senado 1218 ya se encuentra sustancialmente atendida mediante el Programa de Detección, Diagnóstico y Tratamiento Temprano y Periódico (EPSDT),

financiado bajo Medicaid y CHIP. Tanto el Departamento de Salud como la Administración de Seguros de Salud coincidieron en que dicho programa ofrece evaluaciones médicas periódicas, integrales y obligatorias para los menores de veintiún años, cuyo alcance supera una evaluación médico-deportiva limitada exclusivamente a la práctica deportiva, razón por la cual estiman que la medida resultaría redundante desde la perspectiva clínica y programática.

Asimismo, los comentarios de la AAFAF evidencian la ausencia de un análisis fiscal y actuarial que permita determinar el costo recurrente de incorporar un nuevo beneficio mandatorio al Plan Vital. La falta de un informe de impacto fiscal y de una fuente de financiamiento alterna identificada impide evaluar la compatibilidad de la medida con el Plan Fiscal certificado, el presupuesto balanceado y los principios de responsabilidad fiscal que rigen la administración pública.



De igual forma, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico identificó deficiencias sustanciales en la redacción de la medida relacionadas con la ausencia de definiciones, criterios clínicos uniformes, delimitación del universo de participantes y el tratamiento desigual entre estudiantes cubiertos por el Plan Vital y aquellos con seguros privados. Tales omisiones podrían generar incertidumbre jurídica, dificultades operacionales y cargas económicas no previstas para numerosas familias.

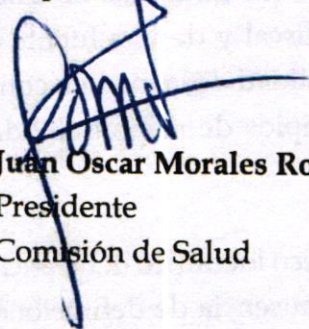
Aunque el Departamento de Recreación y Deportes favoreció la aprobación de la medida y propuso enmiendas dirigidas a fortalecer su implantación, la Comisión entiende que dichas recomendaciones, lejos de subsanar aspectos menores, ponen de manifiesto que el Proyecto requiere una revisión técnica y normativa considerable antes de ser considerado para su aprobación.

En consecuencia, la Comisión concluye que la intención legislativa de proteger la salud de los menores atletas resulta encomiable; sin embargo, la medida, según redactada, no demuestra necesidad legislativa frente a la cubierta existente, carece de un análisis fiscal suficiente y presenta vacíos regulatorios que impiden su implantación uniforme. Por ello, recomienda que cualquier iniciativa futura sobre esta materia sea precedida por un análisis interdisciplinario que incluya la evaluación de las agencias concernidas, un estudio actuarial de costos y una delimitación normativa clara sobre su alcance, contenido clínico, mecanismos de financiamiento y aplicación a los distintos sistemas de aseguramiento médico.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su **Informe Negativo** sobre el **Proyecto del Senado 1218**, No Recomendando su aprobación.

Respetuosamente sometido,



Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud